Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível do Foro Regional do 4º Distrito da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 14º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110-230 - Fone: (51) 321-06500 - Balcão virtual: (51) 98010.4411 - Email: frpoareg4d2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5004879-07.2023.8.21.1001/RS

AUTOR: LIVIA MACHADO DA FONSECA

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Vistos.

LIVIA MACHADO DA FONSECA, devidamente qualificada nos autos, ajuizou **AÇÃO ORDINÁRIA** em face de **BRADESCO SAUDE S/A**, igualmente qualificado, alegando, em síntese, ser diagnosticada com episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID 10 F32.2), resistente a tratamentos farmacológicos convencionais. Relata que seu médico psiquiatra, Dr. Leonardo Ludwig Paim (CREMERS 28195), prescreveu, com urgência, o tratamento contínuo com o medicamento Cloridrato de Escetamina intranasal, de nome comercial Spravato 28mg, na dose de 84mg por aplicação (3 dispositivos), duas vezes por semana. Sustenta que o quadro de depressão resistente já foi submetido, sem sucesso, a diversas terapias, incluindo o uso de medicamentos como sertralina, imipramina e venlafaxina em doses máximas toleráveis. Afirma que o medicamento Spravato possui aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para casos de depressão resistente ao tratamento e que seu uso é exclusivamente hospitalar/ambulatorial, sob supervisão de profissional da saúde. Diante da hipossuficiência financeira para arcar com os custos do tratamento, estimado em R$ 72.697,81, solicitou a cobertura junto ao plano de saúde réu, que negou o pedido. Fundamenta sua pretensão no Código de Defesa do Consumidor, e no direito constitucional à saúde e à vida digna. Requereu, liminarmente, que a ré fosse compelida a custear o tratamento prescrito, incluindo o medicamento e sua aplicação no Ambulatório de Psiquiatria Intervencionista do Hospital São Lucas da PUC/RS e, ao final, a confirmação da liminar, com a procedência total dos pedidos. Com a inicial, juntou documentos e postulou AJG (evento 1).

Deferida a AJG, foi igualmente deferida a liminar pleiteada a fim de que a requerida custeasse e disponibilizasse o tratamento com o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) nos moldes indicados pelo médico especialista (evento 3).

Interposto recurso (Agravo de Instrumento Nº 5342475-94.2023.8.21.7000/RS), a decisão restou mantida pela Superior Instância.

Citada, a requerida apresentou contestação, argumentando, em síntese, que o medicamento pleiteado não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a patologia da autora. Sustentou a taxatividade do referido rol, sendo a cobertura obrigatória apenas para o que ali está expressamente previsto. Alegou a ausência de obrigatoriedade de custeio de tratamento de uso ambulatorial e a existência de exclusão contratual para medicamentos não previstos no rol da ANS. Defendeu a legalidade da negativa e a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar, pugnando pela total improcedência da ação (evento 19).

Houve réplica (evento 27).

Prolatado despacho saneador e instadas as partes para se manifestarem acerca do interesse na produção de outras provas (evento 45), estas não postularam a dilação probatória (eventos 50 e 51).

Vieram-me os autos conclusos para a prolação de sentença.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Trata-se de **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **LIVIA MACHADO DA FONSECA** em face de **BRADESCO SAUDE S/A** em que entendo cabível o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que, além da desnecessidade de produção de prova em audiência, as partes, embora devidamente instadas para tanto, não postularam a produção de outras provas.

Inexistem preliminares pendentes de análise, razão pela qual passo, diretamente, ao julgamento do mérito da ação.

A relação jurídica existente entre as partes é inegavelmente de consumo, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora (destinatária final do serviço) e a ré no de fornecedora de serviços de saúde, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Dessa forma, a análise da controvérsia deve pautar-se pelos princípios e normas do microssistema consumerista, que visam proteger a parte vulnerável da relação , interpretando-se as cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, conforme preceitua o artigo 47 do CDC.

A controvérsia central da demanda, assim, reside na obrigatoriedade ou não do plano de saúde réu em custear o tratamento da autora com o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), prescrito por seu médico assistente, tendo a requerida fundamentado a sua negativa de cobertura na alegada ausência de previsão do tratamento no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

No presente feito, o laudo médico que acompanhou a exordial, subscrito pelo Dr. Lucas Spanemberg (CREMERS 29169), é claro e detalhado ao descrever o quadro clínico da autora como *"episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos, resistente a tratamento"* (CID-10 F32.2).

O aludido documento atesta, de forma inequívoca, que a paciente já se submeteu a diversas tentativas de tratamento farmacológico, incluindo três classes de antidepressivos (sertralina, imipramina e venlafaxina) em doses máximas, sem apresentar a resposta adequada.

O profissional que acompanha a paciente, inclusive, indicou, em caráter de urgência, a aplicação de Cloridrato de Escetamina intranasal, ratificando a gravidade do quadro e a necessidade da terapia pleiteada.

É cediço que a escolha do tratamento mais adequado ao paciente é de responsabilidade do médico que o assiste, e não da operadora do plano de saúde.

A Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece a obrigatoriedade da cobertura do tratamento de todas as doenças listadas na Classificação Internacional de Doenças (CID).

No caso, a patologia que acomete a autora (CID 10 F32.2) possui cobertura contratual. Assim, se a doença está coberta, não pode a operadora limitar ou excluir os procedimentos e medicamentos necessários ao seu tratamento, sob pena de violação da própria finalidade do contrato, que é a proteção à saúde e à vida do beneficiário.

Ademais, a alegação de que o rol da ANS seria taxativo foi superada com o advento da Lei nº 14.454/2022, que alterou o art. 10 da Lei nº 9.656/98.

A nova legislação estabeleceu critérios para a cobertura de tratamentos não previstos no rol, determinando que a cobertura deve ser autorizada pela operadora desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, ou que haja recomendação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) ou por órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

No caso em apreço, o medicamento Spravato (Cloridrato de Escetamina) possui registro e aprovação pela ANVISA, conforme consulta juntada aos autos , especificamente para o tratamento de "Transtorno Depressivo Maior em adultos que não tenham respondido adequadamente a pelo menos dois antidepressivos diferentes" (depressão resistente ao tratamento) e para a "rápida redução dos sintomas depressivos em pacientes adultos com Transtorno Depressivo Maior com comportamento ou ideação suicida aguda".

O Parecer Público de Avaliação do Medicamento emitido pela própria ANVISA detalha os estudos clínicos de fases 2 e 3 que corroboram a eficácia e segurança do fármaco para a condição da autora.

A jurisprudência pátria, inclusive do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é pacífica no sentido de reconhecer o dever de cobertura em casos análogos, vejamos:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA). COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA. EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS. NOTA TÉCNICA FAVORÁVEL. DEVER DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. OS CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE DEVEM SER INTERPRETADOS À LUZ DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ISTO É, DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO HIPOSSUFICIENTE. O TRATAMENTO PRESCRITO, AINDA QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS, FOI INDICADO POR SER O ÚNICO TRATAMENTO EFICAZ COM INDICAÇÃO EM BULA PARA PACIENTES COM DEPRESSÃO MAIOR E IDEAÇÃO SUICIDA, CASO DOS AUTOS. AINDA, EM CONSULTA AO SISTEMA E-NATJUS, CONSTATA-SE A EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PARECER FAVORÁVEL AO USO DO FÁRMACO POSTULADO, SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA), PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. DEVER DE COBERTURA. INTELIGÊNCIA DO ART. 10, §13, I, DA LEI Nº 9.656/98. CONFIGURADA A PROBABILIDADE DO DIREITO, RESTA, AINDA, EVIDENTE O PERICULUM IN MORA, DIANTE DA CONDIÇÃO DE SAÚDE DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Agravo de Instrumento, Nº 50278852020258217000, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mauro Caum Gonçalves, Julgado em: 28-03-2025).*

> *APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COBERTURA DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL). USO AMBULATORIAL. ROL DA ANS. MITIGAÇÃO. DEVER DE COBERTURA. APELO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO EM FACE DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINANDO A COBERTURA PELA DEMANDADA DO MEDICAMENTO SPRAVATO (CLORIDRATO DE ESCETAMINA INTRANASAL) PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM VERIFICAR A OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DO TRATAMENTO POSTULADO EM RAZÃO DE TRATAR-SE DE MEDICAMENTO DE USO AMBULATORIAL, NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. III. RAZÕES DE DECIDIR3. EMBORA AS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE ESTEJAM DISPENSADAS DE FORNECER MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR, EXCETO ANTINEOPLÁSICOS, NO CASO CONCRETO, É INCONTROVERSO QUE O MEDICAMENTO SOLICITADO É DE USO AMBULATORIAL. 4. O MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR DE QUE TRATA O ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 É AQUELE PRESCRITO PELO MÉDICO, ADQUIRIDO DIRETAMENTE NAS FARMÁCIAS E AUTOADMINISTRADO PELO PACIENTE, DIFERENTE DO CASO DOS AUTOS ONDE O MEDICAMENTO PRESCRITO SERÁ ADMINISTRADO EM AMBULATÓRIO, COM SUPERVISÃO MÉDICA. 5. O ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS É TAXATIVO, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS PREVISTAS NA LEI Nº 14.454/2022, COMO EFICÁCIA COMPROVADA POR EVIDÊNCIAS*

CIENTÍFICAS OU RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃOS TÉCNICOS RECONHECIDOS. 6. EXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DA EFICÁCIA DO TRATAMENTO COM O MEDICAMENTO SPRAVATO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE, QUE JÁ TENHAM TENTADO DIVERSOS OUTROS TRATAMENTOS SEM SUCESSO. 7. CONFIGURADA HIPÓTESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS E DAS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA O TRATAMENTO, SENDO DEVIDA A COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. IV. DISPOSITIVO8. APELO NÃO PROVIDO. (Apelação / Remessa Necessária, Nº 50058092520238211001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 27-02-2025)

Portanto, a eficácia do medicamento está cientificamente comprovada e sua indicação para o quadro de depressão resistente é expressa, preenchendo os requisitos da Lei nº 14.454/22 para a cobertura obrigatória.

A recusa do plano de saúde, neste contexto, revela-se abusiva, por colocar a consumidora em desvantagem exagerada e restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, em violação ao art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Consigno, ainda, que a própria Superior Instância, quando do julgamento do Agravo de Instrumento Nº 5342475-94.2023.8.21.7000/RS, reconheceu, ainda que num juízo de provisoriedade, a obrigação do requerido ao custeio do tratamento reclamado, consoante decisão que adiante colaciono e fundamentação que ora também adoto como razão de decidir, *in verbis:*

Após as alterações na Lei dos Planos de Saúde operadas pela Lei n. 14.454/2022, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da ANS passou a constituir apenas a referência básica para os planos privados, conforme redação expressa do § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, sendo que este mesmo dispositivo de lei, em seu inciso VI, autoriza às operadoras dos planos de saúde excluírem a cobertura para fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral e medicamentos de uso em *home care*.

> *Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;*
>
> *(...)*

Transcrevo o mencionado art. 12, na parte em que prevê as exceções à regra que dispensa a cobertura para medicamento de uso domiciliar:

> *Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:*
>
> *I - quando incluir atendimento ambulatorial:*
>
> *(...)*
>
> *c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;*
>
> *II - quando incluir internação hospitalar:*
>
> *(...)*
>
> *g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;*

Portanto, conforme interpretação do texto legal, as operadoras de planos de saúde estão dispensadas de fornecer medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos e medicamentos de uso em *home care*.

Presente o teor do art. 10, VI, acima transcrito e o disposto no art. 47 do CDC, segundo o qual o contrato deve sempre ser interpretado favoravelmente ao consumidor, a limitação de cobertura não abrange medicamentos de uso ambulatorial, hipótese em exame.

Sobre o tema, reproduzo definição da Quarta Turma do STJ ao julgar, por exemplo, o AgInt no AREsp n. 1.771.350/PR (DJe de 22.09.2023):

> *Ainda sobre a questão, esta Corte entende que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98 é aquele prescrito pelo médico adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.*

No caso, a agravada é portadora de depressão grave e, ante a resistência do quadro, foi-lhe prescrito tratamento com o medicamento cloridrato de escetamina intranasal (Spravato), conforme consta do laudo médico:

> Paciente vem para a avaliação no ambulatório de psiquiatria intervencionista do Hospital São Lucas da PUCRS com indicação de escetamina intranasal pelo seu psiquiatra assistente com quadro de depressão resistente a diversas tentativas de tratamento farmacológico, incluindo três classes de antidepressivos (sertralina, imipramina e venlafaxina), atingindo doses máximas toleráveis sem resposta adequada, incluindo potencialização com antipsicóticos atípicos e bupropiona. Atualmente encontra-se em uso de bupropiona 300mg e brexpiprazol 2mg.
>
> A avaliação confirmou a gravidade do quadro de depressão resistente e a indicação da Escetamina Intranasal, com urgência. O cloridrato de escetamina intranasal (nome comercial Spravato) está aprovado pela ANVISA para o tratamento de depressão resistente ao tratamento e/ou com risco de suicídio.
>
> Ratificamos a indicação desse procedimento e nos colocamos à disposição para iniciar o tratamento tão logo haja liberação da operadora de saúde.

De acordo com a recomendação médica, o medicamento deveria ser aplicado em ambulatório (**evento 1, OUT6**).

Até porque a bula do medicamento indica a administração por profissional de saúde em estabelecimento de saúde (**evento 1, OUT9**):

> **8. POSOLOGIA E MODO DE USAR**
>
> O **Spravato®** deve ser administrado em combinação com terapia antidepressiva (AD) oral.
>
> Uma sessão de tratamento consiste na administração nasal de **Spravato®** e na observação pós-administração sob a supervisão de um profissional de saúde. **Spravato®** deve ser administrado em um estabelecimento de saúde sob observação de um profissional de saúde e o paciente deve ser monitorado até ser considerado clinicamente estável e pronto para deixar o estabelecimento.
>
> O **Spravato®** é somente para uso nasal. O dispositivo de spray nasal é um dispositivo de uso único que distribui, no total, 28 mg de escetamina em dois jatos (um jato por narina). Para prevenir a perda de medicamento, o dispositivo não deve ser ativado antes do uso. É destinado para administração pelo paciente sob a supervisão de um profissional de saúde, usando 1 dispositivo (para uma dose de 28 mg), 2 dispositivos (para uma dose de 56 mg) ou 3 dispositivos (para uma dose de 84 mg), com um repouso de 5 minutos entre o uso de cada dispositivo.

Assim, com base nos argumentos retro expendidos, entendo que a procedência do pleito autoral é medida que se impõe.

POSTO ISSO, CONFIRMANDO a liminar anteriormente deferida, JULGO **PROCEDENTES** os pedidos formulados na presente **AÇÃO ORDINÁRIA** ajuizada por **LIVIA MACHADO DA FONSECA** em face de **BRADESCO SAUDE S/A**, a fim de reconhecer a obrigação da requerida em custear e fornecer, de forma contínua e nos exatos termos da prescrição médica, o tratamento com o medicamento Cloridrato de Escetamina (Spravato), incluindo sua aplicação em ambiente ambulatorial/hospitalar adequado, conforme relatório médico juntado aos autos, enquanto perdurar a necessidade clínica.

Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos procuradores da parte autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido

Em face da nova sistemática do Código de Processo Civil e, diante da inexistência de juízo de admissibilidade (art. 1010, § 3º do CPC), em caso de interposição de recurso de apelação, proceda-se na intimação da parte apelada para que apresente contrarrazões, querendo, no prazo de 15 dias.

Decorrido o prazo, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do RS.

Oportunamente, com o trânsito em julgado e no silêncio das partes, arquive-se o feito com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **LAÉRCIO LUIZ SULCZINSKI, Juiz de Direito**, em 07/09/2025, às 17:04:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10089260013v17** e o código CRC **2a057fb9**.